♪ HSP×心のチューニング ♪

心のチューニング
5分リセット習慣7選

論文をもとにした、今日からできる小さなケア



心地よく、自分らしく、自由に。

もの | 優しい世界を届ける

INTRODUCTION

はじめに

このPDFを手に取ってくれて、ありがとうございます。

人混みのあと、ぐったりする。
誰かの不機嫌に、一日中引っ張られる。
寝る前に、今日の会話を何度も思い返してしまう。
休日を寝て過ごして、そんな自分にまた落ち込む。

もしひとつでも当てはまるなら、伝えたいことがあります。

疲れやすいのは、
弱いからじゃない。
たくさん感じているから。

心のチューニングとは

繊細な楽器ほど、音がずれやすい。でもそれは壊れているからではなく、小さな振動まで拾って豊かに響く楽器だから。だから繊細な楽器ほど、こまめに調律します。感じやすさを直すのではなく、ずれた音を自分の音に戻していく。それが心のチューニングです。

わたしについて

わたしも、HSP気質の当事者です。疲れている日は、話し声や物音が大きく聞こえすぎてしまうことがあります。

だからこのPDFでは、研究で確かめられていることの中から、疲れている日でもできるもの、道具なしで5分以内にできるものだけを選びました。ゆっくり、1つずつで大丈夫です。

このPDFの使い方
7つ全部やらなくて大丈夫です。今日の気分で、1つだけ選んでください。後半に、好きな時間リストと7日間の記録表もつけています。

ABOUT HSP

HSPとは

HSP（Highly Sensitive Person）は病名ではなく、心理学で感覚処理感受性と呼ばれる気質のことです。心理学者エレイン・アーロン博士が1990年代に研究を始めました。

2018年の研究では、人口のおよそ3割が感受性の高いグループに入ると推定されています。少数派ではあるけれど、決してひとりではありません。

HSPの4つの特徴（DOES）

- D：物事を深く処理する　→　本質に気づける
- O：刺激を受けすぎやすい　→　変化に早く気づける
- E：感情の反応と共感が強い　→　人を安心させられる
- S：ささいなことに気づく　→　細部の質を上げられる

矢印の先は、同じ特徴を裏返した強みです。

気づきチェック

診断ではなく、自分の傾向に気づくためのものです。

☐　大きな音、強い光、においで疲れやすい

☐　人の表情や声色の変化にすぐ気づく

☐　予定が詰まると、楽しい予定でもしんどくなる

☐　ひとりの時間がないと回復できない

☐　決める前に、たくさん考えてしまう

当てはまる数が多いほど、次のページからの習慣があなたの助けになるはずです。

7 RESET HABITS

7つのリセット習慣

1 吐く息を長くする呼吸

こんな時に：人混みや会議のあと、心臓がざわざわする時

1. 鼻から吸う
2. もう一度、鼻から少しだけ吸い足す
3. 口からゆっくり、長く吐く
4. これを1〜5分くり返す

根拠：スタンフォード大学の研究（Balban et al., 2023）で、1日5分の呼吸法を1ヶ月続けたところ、この方法（サイクリック・サイ）でポジティブな気分の改善が大きかったと報告されています。

2 感情に名前をつける

こんな時に：モヤモヤの正体がわからない時

1. メモ帳を開く
2. 「今わたしは〇〇を感じている」と書く
3. 不安、悲しい、悔しい、さみしい、焦り。一番近い言葉を探す
4. 解決しようとしなくていい。名前をつけたら終わり

根拠：UCLAの研究（Lieberman et al., 2007）で、感情を言葉にすると、不安や恐れに関わる扁桃体の反応が弱まったと報告されています。

3 自分を名前で呼ぶ

こんな時に：自分を責める声が止まらない時

1. 「わたしは」を自分の名前に置き換える
2. 「〇〇は今、疲れているんだね」と、友達に話すように語りかける
3. 最後に、大切な人にかけるような一言を足す

根拠：Kross et al.（2014）で、自分を名前や三人称で呼ぶと、ストレス場面での不安が和らぎやすいと報告されています。

4 聞こえる音を3つ数える

こんな時に：考えごとで頭がいっぱいの時

1. 目を閉じるか、視線を落とす
2. 遠くの音、近くの音、自分の呼吸の音。3つ見つける
3. 良い悪いを判断せず、ただ聞く
4. 考えごとに流れたら、また音に戻る

根拠：Killingsworth & Gilbert（2010）で、人は起きている時間の約47％を今ここ以外のことを考えて過ごし、その時ほど幸福感が低い傾向が報告されています。瞑想プログラムが不安や抑うつの軽減に役立つことは、メタ分析（Goyal et al., 2014）でも示されています。

5 心配ごとを予約する

こんな時に：寝る前に不安がぐるぐるする時

1. 毎日決まった15分を「心配タイム」にする（例：19時から。寝る直前は避ける）
2. それ以外の時間に心配が浮かんだら、メモして「あとで考える」と保留する
3. 心配タイムにメモを見て、今も気になるものだけ考える

根拠：心配を決まった時間に先送りする方法（McGowan & Behar, 2013）で、心配や不安の軽減が報告されています。

6 緑の中に身を置く

こんな時に：同じ悩みを何度も考えてしまう時

1. 帰り道を、木の多いルートに変える
2. 公園のベンチで5分、葉の揺れを眺める
3. 難しい日は、ベランダの植物や空を眺めるだけでOK

根拠：Bratman et al.（2015）で、自然の中を90分歩いた人は都市部を歩いた人に比べ、反すう（ぐるぐる思考）が減ったと報告されています。まずはできる範囲で、小さく取り入れてみてください。

7 好きな音に触れる

こんな時に：心がざらざらして落ち着かない時

1. 雨音、波の音、ピアノなど、心地いいと感じる音を1つ選ぶ
2. 小さめの音量で5分流す
3. その間は、音の高さやリズムだけに耳を澄ませる

根拠：de Witte et al.（2020）のメタ分析で、音楽を取り入れることが心拍や血圧などの体の反応とストレス感の両方を下げると報告されています。大切なのは正解の曲ではなく、あなたが心地いいと感じる音です。

わたしの好きな音メモ

思いつくだけ書いてみてください。

- ☐
- ☐
- ☐

今日の1つを決めよう

いちばんやってみたい番号に丸をつけてください。

1　2　3　4　5　6　7

REST NOTE

休符を置く｜好きな時間の大切さ

休符も、音楽の一部です。休符のない曲は、弾く人も聴く人も苦しくなります。

好きな時間は、がんばったあとのごほうびではありません。ずれた音を、自分の音に戻すための調律です。だから「空いたらやる」ではなく、がんばる前に先に置いてください。

研究でわかっていること

- 余暇を楽しんでいる時ほど、ストレスや悲しみが低く、心拍も落ち着いていたと報告されています（Zawadzki et al., 2015）。
- 16か国、65歳以上の約9万3千人を調べた研究で、趣味がある人ほど抑うつ症状が少なく、幸福感や生活満足度が高い傾向がありました（Mak et al., 2023）。
- 認知行動療法の行動活性化では、楽しめる活動を予定に入れていくことで、気分の落ち込みが軽くなることが示されています（Cuijpers et al., 2007）。
- 感受性の高い人ほど、良い体験から良い影響を受けやすい可能性も示されています（Pluess & Belsky, 2013）。

好きな時間リスト

疲れた心は、選ぶ力も落ちています。元気な今のうちに書いておくと、しんどい日に迷わずにすみます。

かかる時間	好きなこと（3つずつ）
5分	
30分	
休日	

書けたら、今週のカレンダーに1つだけ、先に予定として入れてみてください。

7 DAYS LOG

7日間の記録表

やった習慣の番号と、やる前とやった後の心のざわざわを0〜10で書いてください。できなかった日は、空欄のままで大丈夫です。

日	やった習慣	前	後	ひとことメモ
1日目				
2日目				
3日目				
4日目				
5日目				
6日目				
7日目				

7日間で、いちばん自分に合っていた習慣はどれでしたか？
番号とひとことを、LINEで送ってもらえたらうれしいです。

CLOSING

おわりに

繊細さは、なくすものではありません。
感じたものとの距離の取り方は、練習で身につけられます。

2010年の研究では、感受性の高い人が8週間のマインドフルネス・プログラムに参加したところ、ストレスや社会的不安が減り、自己受容が高まったと報告されています。この7つと好きな時間は、心のチューニングの入り口です。

LINEで、7日間の声のメッセージをお届けします

明日から1日1本、2〜3分ほどの音声が届きます。寝る前や、帰り道に聞ける長さです。

7日後、しんどい日に「こうすれば戻ってこられる」と思える、自分だけの方法が手元に残るように作りました。

大切なお願い

このガイドは医療行為や診断に代わるものではありません。眠れない、食べられない、気分の落ち込みが2週間以上続くなど、日常生活に支障がある時は、心療内科や精神科、公的な相談窓口に相談してください。ひとりで抱えきれない時は、よりそいホットライン（0120-279-338）にも相談できます。通院中の方は、主治医に相談のうえで取り入れてください。

参考文献

Aron & Aron (1997) J Pers Soc Psychol 73(2) / Lionetti et al. (2018) Transl Psychiatry 8:24 / Balban et al. (2023) Cell Rep Med 4(1) / Lieberman et al. (2007) Psychol Sci 18(5) / Kross et al. (2014) J Pers Soc Psychol 106(2) / Killingsworth & Gilbert (2010) Science 330 / Goyal et al. (2014) JAMA Intern Med 174(3) / McGowan & Behar (2013) Behav Modif 37(1) / Bratman et al. (2015) PNAS 112(28) / de Witte et al. (2020) Health Psychol Rev 14(2) / Soons et al. (2010) Eur J Psychol 6(4) / Zawadzki et al. (2015) Ann Behav Med 49(4) / Mak et al. (2023) Nat Med 29 / Cuijpers et al. (2007) Clin Psychol Rev 27(3) / Pluess & Belsky (2013) Psychol Bull 139(4)